



世界卫生组织

艾滋病毒和艾滋病

2025年7月15日 | 阅读时间 10 分钟 (2802 字)

[English](#)

[العربية](#)

[Français](#)

[Русский](#)

[Español](#)

重要事实

- 艾滋病毒仍然是一个重大的全球公共卫生问题，迄今为止估计已夺去4 410万人的生命。该病毒目前在全球所有国家传播。
- 截至2024年底，估计有4080万艾滋病毒感染者，其中65%在世卫组织非洲区域。
- 2024年，估计有63万人死于艾滋病毒相关原因，另有约130万人感染艾滋病毒。
- 针对艾滋病毒感染并无治愈方法。然而，随着人们获得有效的艾滋病毒预防、诊断、治疗和护理措施，包括针对机会性感染的措施，艾滋病毒感染已成为一种可管理的慢性健康疾患，艾滋病毒感染者能够过上健康长寿的生活。
- 世卫组织、全球基金和艾滋病署都制定了全球艾滋病毒战略，这些战略与可持续发展目标的具体目标3.3（到2030年终结艾滋病毒流行）相一致。
- 2024年，在所有艾滋病毒感染者中，有87%的感染者知晓自己的感染状况，77%正在接受抗逆转录病毒治疗，73%病毒载量得到抑制。

概述

人类免疫缺陷病毒（艾滋病毒）攻击人体免疫系统。获得性免疫缺陷综合症（艾滋病）发生在感染的最晚期。

艾滋病毒以人体的白细胞为目标，削弱免疫系统。这使得感染者更容易患上结核病、感染和某些癌症等疾病。

艾滋病毒经由感染者的体液传播，包括血液、母乳、精液和阴道液体。它不会通过亲吻、拥抱或分享食物来传播。病毒也可由母亲传给婴儿。

艾滋病毒可以预防，并可通过抗逆转录病毒疗法(ART)进行治疗。未经治疗的艾滋病毒通常会在多年后发展为艾滋病。

世卫组织现在将晚期艾滋病定义为成人和青少年的CD4细胞计数低于200个细胞/mm³或世卫组织第3期或第4期事件。所有感染艾滋病毒的5岁以下儿童都被认为患有晚期艾滋病，无论其临床或免疫状况如何。

症状和体征

艾滋病毒感染症状和体征视感染阶段而异。

在感染后的最初几个月里，艾滋病毒更容易传播，但许多人直到后期才意识到自身感染状况。在感染后的最初几周内，人们可能不会出现症状。但有些人可能出现流感样疾病，包括：

- 发热
- 头痛
- 皮疹
- 咽痛。

感染会逐渐削弱免疫系统。这可能导致其他一些体征和症状：

- 淋巴结肿大
- 体重减轻
- 发热
- 腹泻
- 咳嗽。

如不加治疗，艾滋病毒感染者也可能患上严重疾病：

- 结核病
- 隐球菌性脑膜炎
- 重度细菌感染
- 淋巴瘤和卡波西肉瘤等癌症。

艾滋病毒可使其他感染状况恶化，如乙肝、丙肝和猴痘。

传播

艾滋病毒可通过与艾滋病毒感染者发生血液、乳汁、精液和阴道分泌物等体液交换而传播。怀孕和分娩期间也可能将艾滋病毒传播给孩子。亲吻、拥抱、握手或共用个人物品、食物或水等一般日常接触不会使人们受到艾滋病毒感染。

正在接受抗逆转录病毒治疗且病毒载量检测不到的感染者不会将艾滋病毒传给他们的性伴侣。因此，及早向艾滋病毒感染者提供抗逆转录病毒药物和支持以使之坚持治疗，不仅对于改善其自身健康，而且对于预防艾滋病毒传播都至关重要。

危险因素

可能使人们感染艾滋病毒的一些高危行为和情况有：

- 不使用避孕套进行肛交或阴道性行为；
- 患有其它性传播感染，如梅毒、疱疹、衣原体、淋病和细菌性阴道炎等；
- 在性行为背景下有害使用酒精或药物；
- 在注射吸毒时共用受到污染的针头、注射器和其它注射器具或药品溶液；
- 接受不安全注射、输血或组织移植；以及
- 涉及未经消毒的切割或刺穿的医疗操作；或包括卫生工作者在内的人不慎被针具刺伤。

诊断

艾滋病毒可通过当天就能得出结果的快速诊断检测法[进行诊断](#)。这大大促进了早期诊断以及与治疗 and 预防措施的对接。人们也可利用艾滋病毒自测法进行自我检测。然而，任何单一检测都不能提供完整的艾滋病毒阳性诊断；需要由合格且经过培训的卫生工作者或社区工作者进行确认检测。在国家批准的检测策略和规则中使用世卫组织预认证的检测方法，可以十分准确地发现艾滋病毒感染状况

最广泛使用的艾滋病毒诊断检测法可发现人体在对艾滋病毒做出免疫应答的过程中所产生的抗体。在多数情况下，人们会在感染后28天内产生艾滋病毒抗体。在此期间，人们处于所谓的“窗口期”，体内抗体水平较低，无法通过许多快速检测方法检测出来，但仍可能将艾滋病毒传播给他人。最近有过高风险暴露且检测呈阴性的人可以在28天后进行进一步检测。

被诊断为病毒阳性的人员在加入治疗和护理方案之前应当再次检测，以排除任何潜在的检测或报告错误。虽然对青少年和成年人的检测已经变得简单有效，但对艾滋病毒阳性母亲所生的婴儿来说却并非如此。对于18个月以下的儿童而言，快速抗体检测并不足以发现艾滋病毒感染——必须在出生时或6周龄时进行病毒学检测。现在可通过新技术在治疗点开展这种检测，并可在当日获得结果，这将加快与治疗 and 护理之间的适当对接。

预防

艾滋病毒是可以预防的疾病。可通过以下方式降低艾滋病毒感染风险：

- 性交时使用男用或女用避孕套
- 进行艾滋病毒和其它性传播感染检测
- 男性接受包皮环切术
- 如注射和使用毒品，则使用减少危害服务。

暴露前预防用药是另一种预防选项。它是一种供艾滋病毒阴性者使用的抗逆转录病毒药物，以降低感染艾滋病毒的风险。世卫组织建议采用以下暴露前预防用药方法：

- 口服基于替诺福韦的暴露前预防药物

- 达匹韦林阴道环
- 长效注射用卡博特韦
- 长效注射用来那帕韦。

抗逆转录病毒药物还可用于防止母亲将艾滋病毒传染给子女。

正在接受抗逆转录病毒治疗且没有证据显示其血液中存在病毒的人不会将艾滋病毒传染给他们的性伴侣。获得检测和抗逆转录病毒治疗是预防艾滋病毒的重要组成部分。

没有艾滋病毒的人服用抗逆转录病毒药物可以预防感染

当药物在可能暴露于艾滋病毒之前使用时称为暴露前预防用药(PrEP)，在暴露后使用时称为接触后预防(PEP)。当感染艾滋病毒的风险很高时，人们可以使用暴露前预防用药或接触后预防；人们在考虑使用暴露前预防用药或接触后预防时应寻求临床医生的建议。

治疗

艾滋病毒感染无法治愈。治疗手段是使用抗逆转录病毒药物，阻止病毒在体内复制。

目前的抗逆转录病毒疗法不能治愈艾滋病毒感染，但可使人体的免疫系统变得更强大。这有助于他们对抗其他感染。

目前，抗逆转录病毒治疗必须终身用药。

抗逆转录病毒治疗可降低人体内病毒的数量。这可以阻止出现症状，让人们过上完整和健康的生活。正在接受抗逆转录病毒治疗且没有证据显示其血液中存在病毒的感染者，不会将艾滋病毒传染给他们的性伴侣。

感染艾滋病毒的孕妇应尽快获得并接受抗逆转录病毒治疗。这可以保护母亲的健康，并有助于防止将艾滋病毒在产前传染给胎儿，或通过母乳传播。

晚期艾滋病仍然是艾滋病毒应对工作中长期存在的问题。世卫组织正在支持各国实施晚期艾滋病一揽子治疗计划以减少发病和死亡。正在针对隐球菌性脑膜炎等机会性感染开发更新的艾滋病毒药物和短期疗法，这可能会改变人们接受抗逆转录病毒治疗和预防药物的方式，包括获得长效注射用制剂的方式，比如现已获得美国食品药品监督管理局批准用于预防艾滋病毒的来那帕韦。

[有关艾滋病毒治疗的更多信息](#)

世卫组织的应对

2022-2030年全球卫生部门关于艾滋病毒、病毒性肝炎和性传播感染的战略（[GHSSs](#)）指导战略应对，以实现到2030年终结艾滋病、乙肝和丙肝以及性传播感染的目标。

世卫组织全球艾滋病毒、肝炎和性传播感染规划推荐在世卫组织及其合作伙伴的支持下，采取共同的、针对特定疾病的国家行动。这些战略考虑到前几年的流行病学、技术和背景变化，促进学习，并创造利用创新和新知识的机会。

世卫组织各规划呼吁覆盖每种疾病影响最大和风险最大的人群，并解决不公平问题。在全民健康覆盖和初级卫生保健框架下，世卫组织各规划致力于实现《2030年可持续发展议程》的目标。